

目 录

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第1期）	13
1. 国家医保局为什么要组织编制立项指南？	13
2. 立项指南中价格项目包括哪些构成要素？	14
3. 立项指南对接落地后，医用耗材如何收费？	14
4. 立项指南是如何体现临床诊疗技术难度差异的？	15
5. 立项指南中，哪些情形未作为加/减收项？	16
6. 加/减收项中的不同编号如何理解？	16
7. 同一价格项目涉及多个加/减收项时，如何计价收费？	16
8. 立项指南中，哪些项目可作为扩展项？	17
9. 立项指南映射关系中的“同主项目/扩展项/加收项收取”“纳入价格构成”两种类型，如何理解？	17
10. 立项指南中哪些项目可执行儿童加收政策？	18
11. 对接落实立项指南，各地应如何把握价格水平制定方法？	19
12. 对接落实立项指南时，不同级别医疗机构间的价格关系应如何把握？	19
13. 立项指南中各种自然腔道内镜治疗或手术应当如何收费？	20
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第2期）	22
1. 中医类价格项目能否在西医科室收费？	22
2. 中医（灸法、拔罐、推拿）类立项指南中的各类灸法是否可单独收取艾条、艾绒费用等？	22
3. 中医推拿治疗不同疾病，且不同疾病的治疗时间均符合收费标准，是否可分别计价收费？	23
4. 手法松解能否同时收取中医推拿费用？	23

5. 中医灸法、推拿等项目能否按医务人员职称加收？	23
6. 中医外治类立项指南是否包含中药饮片？	23
7. 中药贴敷时，多部位贴敷如何收费？	23
8. 患者进行常规针法治疗或特殊针法治疗时，涉及特殊穴位时如何收费？	24
9. 普通电针是否属于仪器针法？	24
10. 部分地区原有“温针灸”如何收费？	24
11. 部分地区原有“热敏灸”如何收费？	24
12. 医疗机构使用子午流注穴位治疗仪进行针灸对应哪个项目收费？	25
13. 关节脱位手法整复能否同时收取骨折手法整复费？	25
14. 骨折手法整复能否同时收取小夹板固定术费用？	25
15. 中医特殊疗法针刀疗法计单位“部位”具体如何理解？	25
16. 中医针法中的特殊穴位如何理解，双侧特殊穴位应当按一个收还是两个收费？ ..	25
17. 中医同时行中医推拿、拔罐、灸法时，是否可以分别收费？	26
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第3期）	27
1. 临床量表评估中的“学科”如何界定？	27
2. 临床量表评估中的扩展项“人工智能”能否按评估条数加收？	27
3. 临床量表评估中的“得出评估结论作为一个完整的计价单位”如何确定？	28
4. 置管护理（深静脉/动脉）、引流管护理、造口/瘘护理等项目计价单位为“管·日” “每造口/每瘘口·日”，门诊治疗完成护理操作，能否收取该项目？	28
5. “精神病人护理”能否与“分级护理”同时收取？	28
6. “新生儿护理”“早产儿护理”能否与“压力性损伤护理”同时收费？	28
7. “重症监护护理”能否收取“气管切开护理”“置管护理（深静脉/动脉）”等其他 专项护理？	28

8. 新生儿护理与重症监护护理能否同时收费？	29
9. 患者在普通病房和重症监护病房之间转入转出时，如何收取护理费用？	29
10. 如危重症、早产儿等医疗机构不允许患者陪护的病房，能否收取“免陪照护费”？	29
11. 按乙类管理的传染病能否收取“严密隔离护理费”？	29
12. 重症监护护理价格构成中有“喂食”，能否同时收取“肠内营养输注护理”？ ..	30
13. 医疗机构为防止患者产生压力性损伤，能否同时收取“压力性损伤护理费”和防褥 疮气垫（床，褥）材料费用？	30
14. 同根管路可同时进行胃肠减压和肠内营养灌注，在对该管路进行护理时，可否分别 收取“引流管护理费”和“肠内营养输注护理费”？	30
15. 护理类立项指南未明确的“吸痰护理费”“呼吸机吸痰护理费”是否停用？ ...	30
16. “气管切开护理费”能否与换药同时收费？	31
17. 护理过程中，护理人员开展的营养风险筛查、呛咳风险评估、生活能力评估等评估 能否按临床量表评估收费？	31
18. “重症监护护理费”单独明确不含监测项目费用，特级护理、I 级护理等分级护理 是否包含监测项目费用？	31
19. 门诊患者病情需要，需留观一段时间，应如何收费？	31
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 4 期）	32
1. 血液透析费等价格项目中的血温、血压等监测事项是否限定由设备完成？	32
2. 血液透析费、血液滤过费等项目价格构成中的“穿刺”具体指什么？是否把深静脉 穿刺费用纳入价格构成？	32
3. 腹膜透析延伸服务费中是否包含医生（护士）上门的费用？	33
4. 腹膜透析操作训练费的封顶线指的是单次培训的封顶，还是全过程中的封顶？ ..	33

5. 腹膜透析换管费、腹膜透析置管费和腹膜透析导管取出费的关系？	33
6. 腹膜透析导管取出费和腹膜透析导管感染清创费能否同时收费？	33
7. 透析治疗过程中，促红细胞生成素、多糖铁复合物、蔗糖铁注射液等透析注射药物可否收取注射器费用、药品费用？生理盐水是否能够收费？	33
8. 透析管路处理过程中，溶栓药物（尿激酶）、抗凝药物（小分子肝素）是否能够单独收费？	34
9. “人工肝治疗”项目如何收费？	34
10. 结肠透析如何收费？	34
11. 患者居家腹膜透析治疗时使用的碘伏帽等如何收费？	34
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第5期）	35
1. 放射检查类立项指南提出“数字影像处理和上传存储服务”的考虑是什么？	35
2. 对于公立医疗机构无法提供符合要求的“数字影像处理和上传存储服务”的，具体减收政策应如何执行？	35
3. 放射检查类立项指南对接落地后，胶片应如何收费？	36
4. 医疗机构进行多个体位脊柱全长X线摄影，能否收取多次影像拼接成像加收费用？	36
5. 医疗机构利用口腔颌面锥形束CT（CBCT）技术检查骨骼、耳乳突、鼻咽部等口腔以外部位，能否收取口腔曲面体层成像费用？	36
6. X线摄影成像（牙片）的计价说明中“以两个牙位为一个部位”，具体指什么？	36
7. 患者单侧乳腺接受两个体位（正位+斜位）的X线摄影的，医疗机构能否收取两次费用？	36
8. 患者同时接受颅脑CT平扫和颅内动脉造影成像的，医疗机构能否分别计费？ ...	37
9. 立项指南使用说明中未明确的血管应如何收费？	37
10. 立项指南使用说明中未明确的部位应如何收费？	37

11. 患者接受单侧上肢多个部位（肱骨、尺骨、肘关节、手部及腕关节）的 X 线摄影成像、计算机体层成像（CT），医疗机构能否收取多个部位费用？..... 38
12. 患者眼部接受 X 线或计算机体层成像（CT）扫描检查时，同时检查眼眶和视神经孔，医疗机构能否收取 3 个部位费用？ 38
13. 医疗机构通过计算机体层（CT）平扫进行骨密度测定，能否同时收取计算机体层（CT）平扫+骨密度测定费用？ 38
14. 患者同时接受腹部平扫、腹部增强和腹主动脉 CTA 检查的，医疗机构应如何计价收费？ 38
15. 医疗机构通过图像重建，实现薄层效果，能否收取计算机体层成像（CT）平扫-薄层扫描加收？ 39
16. 患者同时接受磁共振平扫和磁共振水成像检查的，医疗机构能否收取两次费用？ 39
17. 磁共振检查中除使用说明中已经明确的“特殊方式成像”外，医疗机构能否自行增加其他成像方式？ 39
18. 磁共振特殊方式成像中包含磁共振波谱分析，患者同时接受氢谱、磷谱的波谱分析检查，医疗机构能否叠加收费？ 39
19. 患者接受头颅磁共振（MR）平扫成像（血管）检查，医疗机构能否收取“平扫+血管”费用？ 40
20. 患者同时接受磁共振平扫和弥散成像检查，医疗机构应如何计价收费？ 40
21. 患者同时接受左右髋关节磁共振（MR）检查，医疗机构能否按两个部位收取费用？ 40
22. 放射检查类立项指南落地后，部分地区原有医学影像快速诊疗分析等价格项目如何收费？ 40
23. 如患者首日磁共振平扫后发现异常，次日再次进行磁共振平扫-特殊方式成像，次

日能否按磁共振（MR）平扫-特殊方式成像（加收）计费？	41
24. 患者同一部位接受放射性核素平面显像（静态）+（动态）检查的，医疗机构能否同时收取两项费用？	41
25. 医疗机构自制的 PET-CT 对比剂，没有药字号，应如何计价收费？	41
26. 患者同时接受甲状腺有效半衰期测定、甲状腺激素抑制显像、促甲状腺激素兴奋显像等检查时，医疗机构能否按检查次数收取甲状腺摄碘 131 试验费用？	41
27. 医疗机构利用核素标记法同时测定血容量和红细胞寿命时，应如何计价收费？ .	42
28. 患者同时接受介入肾图和肾图检查时，医疗机构能否同时收取肾图和干预肾图加收项？	42
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 6 期）	43
1. 医疗机构开展常规彩超检查时，根据需要对患者同一部位进行不同体位检查的，能否按体位数量计价收费？	43
2. 临床科室自行配置超声设备开展超声检查，能否收取超声检查费用？	43
3. 医疗机构利用同台设备在床旁开展彩色多普勒超声检查（常规）和彩色多普勒超声检查（血管），能否收取多次床旁加收费用？	43
4. 医疗机构开展超声检查时，单次检查多个部位的体表软组织，能否分别计价收费？	44
5. 医疗机构开展超声检查时，单次检查多个部位的周围神经，能否分别计价收费？	44
6. 医疗机构开展超声检查时，单次检查多个部位的浅表淋巴结（含颈部、腋窝、腹腔、腹股沟）能否分别收费？	44
7. 医疗机构单次颅内血管检查同时涉及发泡试验、CO ₂ 试验两项试验，应如何收费？	44
8. 医疗机构进行膀胱残余尿量、胆道收缩功能等对比检查时，应如何收费？	44
9. 医疗机构能否同时收取彩色多普勒超声检查（胎儿）和扩展项“胎儿血流动力学检查”？	45

10. 医疗机构具体应如何收取可疑胎儿产前诊断费用？	45
11. 医疗机构开展胎儿三维/四维超声重建成像，能否收取彩色多普勒超声检查（常规）-立体成像（加收）费用？	45
12. 胃肠道造影中使用五谷造影剂等非药品类对比剂，能否单独收费？	45
13. “彩色多普勒超声检查（弹性成像）”计价单位为“器官”，应如何理解？	45
14. 医疗机构能否同时收取“彩色多普勒超声检查（弹性成像）”和“彩色多普勒超声检查（常规）”？	45
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第7期）	47
1. 医疗机构提供体检服务的，应如何收费？	47
2. 基层医疗机构如何收取一般诊疗费和门诊诊查费？	47
3. 患者复诊或在换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗等长疗程治疗过程中，医疗机构能否多次收取诊查费？	47
4. 医疗机构提供非免疫规划疫苗接种服务的，能否收取诊查费？	48
5. 医疗机构能否同时收取急诊诊查费（留观）和急诊诊查费（普通）？	48
6. 会诊费（院内）计价单位为“学科·次”，多个学科参与会诊时，医疗机构如何收费？	48
7. 营养科、影像科、病理科等参加会诊，医疗机构能否收取会诊费？	48
8. 患者携带外院影像资料就诊时，医疗机构如何收费？	48
9. 单次诊疗过程中，医疗机构能否同时收取多学科诊疗费与会诊费？	49
10. 同一天内医疗机构为同一名患者进行多次远程会诊，能否多次收费？	49
11. 医疗机构能否同时收取会诊费（远程会诊）与互联网诊查费？	49
12. 医疗机构开展远程会诊，应如何收费？	49
13. 医疗机构邀请外地专家来本院坐诊，应如何收费？	49

14. 医疗机构邀请外地专家前来本院会诊的，应如何收费？	50
15. 医疗机构开展互联网复诊，能否按医师级别收费？	50
16. 医疗机构在救护车转运患者过程中，提供心电监护，能否收取远程监测费？ ...	50
17. 医疗机构为患者提供动态心电图（Holter 检测），进行居家监测时，能否收取远程监测费？	50
18. 床位费（单人间）的部分床位能否执行政府指导价？	50
19. 新生儿在重症监护病房接受治疗的情况下，医疗机构能否同时收取床位费（重症监护）和新生儿暖箱费？	51
20. 新生儿出生 28 天后，确需进一步暖箱治疗的情况下，医疗机构能否收取新生儿暖箱费？	51
21. 医疗机构设有百级、千级、万级层流洁净标准床位的，如何收取床位费？	51
22. 在患者当天随入随出的情况下，医疗机构如何收取床位费？	51
23. 医疗机构在非病房空间增加床位，能否收取床位费？	51
24. 医疗机构在病房内增加床位，应如何收费？	51
25. 床位费（重症监护）是否限定 ICU 收取？	52
26. 如急诊留观床位符合三人间标准，医疗机构应收取床位费（急诊留观），还是床位费（三人间）？	52
27. 医疗机构能否同时收取救护车转运费和上门服务费？	52
28. 医疗机构为非急救患者提供转运服务，应如何收费？	52
29. 病历复制费能否作为医疗服务价格项目收费？	52
30. 医疗机构提供家庭病床建床服务，应如何收取家庭病床建床费？	53
31. 医疗机构开展院内抢救时，能否收取心脏电除颤和气管插管费用？	53
32. 医疗机构实施心肺复苏术后，患者未能恢复自主循环和呼吸，能否收取心肺复苏	

费？	53
33. 医疗机构收取安宁疗护费时，能否同时收取免陪照护费？	53
34. 传染病专科医院未满足单间收治要求，能否收取严密隔离护理？	53
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 8 期）	54
1. 医疗机构开展放疗模拟定位中的 MR、PET-CT 等特殊影像模拟定位时，能否同时收取 MR、PET-CT 检查费？	54
2. 医疗机构利用具备适形、调强、立体定向等多种治疗模式的设备开展治疗的，如何计价收费？	54
3. 医疗机构制定放疗计划时，涉及患者不同部位的，能否按部位收取放疗计划制定费？	55
4. 医疗机构开展康复训练时，能否收取其他物理治疗项目费用？	55
5. 未明确区分团体或个体的康复训练，医疗机构能否进行团体训练？	55
6. 医疗机构通过多种检查方式（徒手肌力检查、关节活动度检查等）得出运动功能障碍诊断的，能否按项收取运动功能检查费？	55
7. 医疗机构同时去除干细胞中多种成分，如何计费？	55
8. 医疗机构如何处理血液辐照费和辐照血收费的关系？	56
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 9 期）	57
1. 医疗机构开展心理治疗（家庭）、康复治疗（家庭）的，如何收费？	57
2. 医疗机构同时为多名患者开展心理治疗（团体）的，应如何收费？	57
3. 医疗机构为患者提供个体、团体等多种形式心理治疗的，能否分别计费？	57
4. 精神康复治疗中所称的“专业人员”，医保部门是否有具体资质要求？	58
5. 医疗机构开展心理治疗、康复治疗的，能否按医务人员职称加收？	58
6. 医疗机构通过线上实时视频交互手段提供心理咨询的，能否收取心理咨询费？ ..	58

7. 医疗机构收取精神科监护时，能否同时收取精神康复治疗等其他费用？	58
8. 医疗机构为非重性精神疾病患者提供的监护事项，如何收费？	58
9. 医疗机构能否保留精神病首诊或门诊诊查费中的精神科加收？	58
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 10 期）	60
1. 医疗机构能否保留岩盐气溶胶治疗价格项目？	60
2. 医疗机构使用多种能量源进行支气管镜特殊治疗的，能否叠加计费？	60
3. 医疗机构开展肺段、肺叶、全肺切除的，能否收取淋巴清扫费？	60
4. 医疗机构开展皮肤微生物检查的，能否收取检验费？	61
5. 医疗机构进行皮肤镜检查，涉及多个视野，能否收取 2 次费用？	61
6. 医疗机构收取烧伤抢救费时，能否同时收取院内抢救费？	61
7. 医疗机构点痣时，应如何收费？	61
8. 体被系统中的面积指肿物面积还是切除皮肤的面积？	61
9. 外科手术中，患者自愿进行美容减张缝合的，医疗机构能否收费？	61
10. 皮肤生理指标检查除立项指南已规定的指标外，其他指标是否能够收费？	62
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 11 期）	63
1. 同台手术中，医疗机构采取多种麻醉方式，开展联合麻醉能否同时收费？	63
2. 医疗机构能否同时收取“麻醉监护下镇静”与“局部麻醉”？	63
3. 医疗机构通过药物吸入等方式进行镇静，能否收取“麻醉监护下镇静”？	64
4. 医疗机构在麻醉监测过程中，开展动脉穿刺置管术、中心静脉穿刺置管术等，能否单独收费？	64
5. 医疗机构开展麻醉时，能否同时收取有创/无创呼吸机辅助通气？	64
6. 麻醉类立项指南使用说明基本物耗中包含钠石灰，医疗机构能否单独收取钙石灰费用？	64

7. 医疗机构针对两个及以上部位使用神经阻滞麻醉，能否多次计费？	65
8. 患者由分娩镇痛下的自然分娩转为剖腹产，医疗机构提供椎管内麻醉或全身麻醉，能否收取相关麻醉费用？	65
9. 医疗机构开展口腔、眼科等治疗或手术时，应收取“局部麻醉费(局部浸润麻醉)”还是“局部麻醉费(神经阻滞麻醉)”？	65
10. 麻醉类价格项目按时长计价收费，医疗机构如何确定麻醉结束时间节点？	65
11. 麻醉过程中，医疗机构开展血气分析等检验项目，能否单独收费？	65
12. 麻醉项目价格构成中包含术中各类监测成本，具体包含哪些监测项目？	66
医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 12 期）	67
1. 医疗机构开展刮宫、人工流产时，能否同时收取宫颈内口检查费？	67
2. 医疗机构开展妇科手术时，能否同时收取子宫动脉结扎费？	67
3. 妇科立项指南中的阴蒂整形费、阴唇整形费和美容整形立项指南中的阴蒂美容整形费、阴唇美容整形费，如何区分和收费？	67
4. 单次子宫活检中，医疗机构同时取子宫内膜、子宫颈、子宫颈内膜三个部位的样本，能否分别计费？	68
5. 医疗机构能否同时收取宫内节育器放置费和宫内节育器取出费？	68
6. 医疗机构为男性患者开展盆底相关手术，能否收取相应费用？	68
7. 医疗机构在同一治疗过程中针对同部位开展臭氧、红外线等不同特殊治疗的，能否收取两次妇科特殊治疗费用？	68
8. 医疗机构针对同部位开展常规治疗或特殊治疗，能否同时收取常规治疗和特殊治疗费？	68

立项指南解读原文链接

1. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第1期）](#)
2. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第2期）](#)
3. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第3期）](#)
4. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第4期）](#)
5. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第5期）](#)
6. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第6期）](#)
7. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第7期）](#)
8. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第8期）](#)
9. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第9期）](#)
10. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第10期）](#)
11. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第11期）](#)
12. [医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第12期）](#)

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第1期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2025年9月29日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第1期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导 （第1期）

1. 国家医保局为什么要组织编制立项指南？

长期以来，医疗服务价格实行属地管理，由地方医药价格主管部门制定价格项目、确定价格水平，地区间价格项目数量、内涵、颗粒度差异较大，部分地区按操作流程、岗位分工等拆分价格项目，不利于医疗机构计费，不利于患者付费和监督管理，也不利于兼容新技术。对此，党中央、国务院高度重视，要求规范管理医疗服务价格项目，使价格项目更好计价、更好执行、更好评价，更能适应临床诊疗和价格管理需要。国家医保局坚决贯彻决策部署，扎实推进深化医疗服务价格改革试点，把统一规范价格项目作为重要改革任务，组织临床和价格专家团队研究编制立项指南，以此来统一指导各地规范价格项目。

2. 立项指南中价格项目包括哪些构成要素？

立项指南价格项目由 7 个核心要素构成，分别是项目名称、服务产出、价格构成、加收项、扩展项、计价单位和计价说明。各地医保部门对接落实各批次立项指南，应依照上述体例和要素对原有价格项目中“项目内涵”“除外内容”等要素进行整合删减，实现价格项目规范统一。

3. 立项指南对接落地后，医用耗材如何收费？

按照《深化医疗服务价格改革试点方案》确定的改革目标，“医用耗材从价格项目中逐步分离，发挥市场机制作用，实行集中采购、‘零差率’销售”，医疗服务和医用耗材价格管理的总体方向：一是医疗服务价格“纯化”，聚焦技术劳务价值；二是医用耗材价格“显化”，进一步适用药品价格管理的成熟经验和工具；三是通过 DRG、DIP 等支付工具的约束，引导医疗机构选择质优价宜的医用耗材、适量适度使用医用耗材。按照上述思路，立项指南主要对医疗服务价格项目进行整合，涉及医用耗材收费的问题大体分为三种情况：

一是“基本物耗”。立项指南的“使用说明”中按类别名称明确的基本物耗，主要是不应或不必要与价格项目分割的易耗品。基本物耗的采购成本计入医疗服务项目价格，因此医疗机构不得向患者额外收取费用。

二是“基本物耗”中类别名称相同、功能特殊的同类产品。立项指南中的基本物耗是类别概念，不是具体的产品概念，客观上存在大的分类相同、具体功能不同的情况，比如“纱布”和“带有特殊止血效果的功能纱布”，假设后者确需作单独收费处理，需要符合以下条件：（1）具有特殊功能、临床必须使用、合并计费不能覆盖成本；（2）在当地医药集中采购平台阳光挂网采购；（3）从基本物耗中排除时，同步配套项目价格的基本物耗减收政策。

三是“基本物耗”之外的其他一次性耗材。此类耗材单独计费符合原则，也是改革方向。然而，改革的理想状态是集中采购、支付方式等措施能够实现对此类耗材价格的制约作用，目前各地的管理实践尚有距离。在过渡期间，各省基于当地管理实际，需要界定单独收费医药耗材范围的，可暂时沿用原政策确定的范围，或者将原政策确定单独收费耗材与对应的价格项目切割，编制综合性目录清单，确保不影响患者正常使用医用耗材和报销。

4. 立项指南是如何体现临床诊疗技术难度差异的？

考虑临床诊疗情形复杂多样，价格项目和价格水平客观上无法细化到同一医疗服务的所有诊疗类型、所有具体情形、所有操作难度，无法确保医院在面对每一名患者、实施每一步操作时都必有收费、必有盈余。一项医疗服务的定价以能够覆盖绝大部分具体情形的成本为原则，有盈有亏、以盈为主、总体平衡既是客观情况，也是定价原则，价格水平无法保障所有情况下医疗机构都能实现盈余，这也不符合坚持公益性导向的改革需求。

同时，立项指南考虑到临床诊疗多样性，采取两种方式体现技术难度差异。第一种是设立加/减收项，针对技术难度差异能够纯化为单一要素的情况设立加减收项，主要包括服务对象加收（儿童、80周岁以上老年人）、实施部位加收（脊柱、眼耳口鼻等美学功能区）、操作难度加收（涉及淋巴结清扫的恶性肿瘤）、简易检查减收（便携睡眠神经多导监测减收）等。此外，在诊查、中医针法等少部分价格项目按照医师级别（主任医师、副主任医师等）实施加收政策，体现优质优价。第二种是分档定价，针对复杂情况多样，且难以纯化为单一要素的情况，立项指南对部分治疗和手术项目类区分常规和复杂情况，分档差异化定价，并在计价说明中对复杂情况的具体内容进行解释。例如，“肺叶切除费（复杂）”中

的“复杂”指：袖状肺叶切除、复合肺叶切除、术中进行血管成形的情况。

5. 立项指南中，哪些情形未作为加/减收项？

以下情况未作为价格项目的加/减收项，由地方医保部门通过优化调整价格水平回应临床需求：一是少数治疗或手术中可能涉及的额外步骤，例如手术过程中的组织松解、支架置入时的球囊扩张等；二是因少数复杂病例时间延长、数量增加所产生的额外资源消耗；三是已基本替代开放手术，成为主流的微创手术，如呼吸、泌尿等类别立项指南中的腔镜手术等。对于上述情形，省级或有定价权限的医保部门按照大数法则、量价加权等原则制定价格水平，平衡医疗机构与患者的双方利益。

6. 加/减收项中的不同编号如何理解？

立项指南中加/减收项对应 15 位医疗服务项目编码的最后两位，简称“加收码”。其中加收码的第 1 位代表加/减收的不同类别，加收码的第 2 位代表同一类别下的不同情况。需要说明的是，加收码第 1 位不同的可叠加收取，加收项第 1 位相同的不能叠加收取。例如，“01 儿童加收”和“11 主任医师加收”分属不同类别，可以叠加收费；再如“体静脉肺动脉吻合费”中的加收项“01 双侧吻合”和“02 全腔吻合”同属一个类别，不得叠加收费。

器官移植、临床量表、中医外治、中医（推拿、灸法、拔罐）、口腔种植、辅助生殖、中医骨伤、产科 8 批立项指南加/减收项按自然序列排列，应据实确定是否叠加收费。

7. 同一价格项目涉及多个加/减收项时，如何计价收费？

立项指南价格项目中加/减收项的具体加/减收标准（加/减收率或加/减收金

额)由省级或有定价权限的医保部门制定。如同一价格项目同时涉及多个加/减收项,需以项目单价为基础,分别计算各加/减收项对应的金额后进行汇总收费。例如:某A项目单价为100元,其中加收项1加收30%(对应金额30元),加收项2加收40%(对应金额40元),减收项1减收20%(对应金额20元),当这些加/减收项同时发生时,最终收费方式统一为 $100+100*30\%+100*40\%-100*20\%=150$ 元。

8. 立项指南中,哪些项目可作为扩展项?

扩展项主要包括以下两类情况:一是实现同一治疗目的而采用的不同治疗方式,且这些方式在资源消耗、技术难度方面相近,价格水平也趋于一致。例如,“心音图”“心阻抗图”均属于“无创血流动力学检查”的不同方式,“泪道造影”与“T管造影”均属于“X线造影”主项目下引入造影剂的不同方式,这类情况会被列为扩展项。二是同一服务产出下,因技术创新带来的检查治疗方式迭代更新,如人工智能辅助、异种器官移植等,也会被纳入扩展项范围。

9. 立项指南映射关系中的“同主项目/扩展项/加收项收取”“纳入价格构成”两种类型,如何理解?

映射项目根据映射方式不同可分为两种类型:一是同主项目/扩展项/加收项收取,即映射项目作为主项目的不同实施方式,直接按主项目标准收费。例如,纯音听阈测定、听力筛选试验、定向条件反射测定均为听阈检查的不同方式,实际收费时按“听阈检查费”主项目标准收取。如医疗机构在符合临床诊疗规范的情况下,同时开展以上三项检查的,可按“听阈检查*3”计价收费,次数应与医嘱单的检查项目数量一致。同时开展多个映射项目,是否能收取多个主项目,应视情况具体分析。二是纳入价格构成,在主项目价格中予以体现,不再单独计价

收费，例如“麻醉术前访视”“麻醉术后随访”作为麻醉类价格项目的价格构成，不再单独收费。

10. 立项指南中哪些项目可执行儿童加收政策？

2012 年，国家发展改革委、卫生部、国家中医药管理局《关于规范医疗服务价格管理及有关问题的通知》（发改价格〔2012〕1170 号）规定了儿童加收政策的基本范围和水平，即“有创活检和探查、临床手术治疗（含麻醉）等项目执行 6 岁以下儿童加收政策，加收比例不超过 30%。

立项指南回应临床呼声，进一步拓宽儿童加收政策的适用范围。一是手术类项目全面实行儿童加收政策，加收比例或金额由省级或有定价权限的医保部门制定。手术类项目具体范围以《全国医疗服务项目技术规范（2023 年版）》分类为参考，技术规范中手术类和治疗类项目同时映射归入一个立项指南价格项目的，均可按手术类落实儿童加收政策。二是非手术类项目实行儿童加收政策的范围适度扩大，例如眼科验光、肺通气功能检查等，具体以立项指南加收项为准。需要说明的是，可执行儿童加收的价格项目，国家医保信息业务编码标准数据动态维护平台均已赋加收项编码，各省原则上不得擅自增加儿童加收加收项。

医疗服务价格项目的“儿童加收”政策主要是考虑到儿童生理、心理、认知等方面的特殊性，鼓励引导医疗机构为患儿提供专门服务的价格政策，长期作为医疗服务价格政策的重要组成部分。而从患儿家庭角度看，加收政策增加个人负担的效果无法回避，对自费家庭尤为明显。因此，医疗服务价格主管部门历来对此项政策的适用范围比较审慎！

立项指南所称“儿童”，指 6 周岁及以下，即出生至 7 周岁生日当天属于儿童加收政策范围。例如，患者 2020 年 1 月 1 日出生，2027 年 1 月 2 日 0 时后门诊

或住院的，不应再执行儿童加收政策。

11. 对接落实立项指南，各地应如何把握价格水平制定方法？

医疗服务价格实行属地管理，省级医保部门要强化医疗服务价格管理主体责任，制定全省统一的价格基准，指导具有价格权限的统筹地区对照全省价格基准，上下浮动确定实际执行的价格水平。具体来讲，针对“一对一”映射的价格项目，可采取直接平移方式制定价格水平；针对“一对多”映射的价格项目，可参照上年度实际服务量，采用“量价加权”方式制定价格水平。需要提醒的是，针对前后计价单位变化的价格项目，例如由“日”变为“小时”、由“双侧”变成“单侧”，不能简单平移，要根据计价单位对照关系换算平移。

对接落实立项指南时，价格水平要结合年度医疗服务价格动态调整的评估综合把握，有条件做增量的要抓住窗口期协同解决项目和价格面临的矛盾，该涨的可以涨；没有条件做增量的原则上坚持平移处理，不能绕过调价机制、违背评估结果大幅涨价。

12. 对接落实立项指南时，不同级别医疗机构间的价格关系应如何把握？

各地对接落实立项指南时，应结合人民群众就医需求变化和医疗服务供给的实际情况，同步推进理顺不同级别医疗机构间不同类型价格项目的合理比价关系。

一是三、四级手术等操作复杂、难度较大、风险较高的手术，建议适当拉开高级别医院与其他技术等级医院的价格差距，以相关省份分级定价，逐级递减 20% 为例，可将三级医院和二级医院的价差调整扩大至 30%-40% 的差距。操作层面主要通过各级别医疗机构同向调增，高级别医疗机构幅度更大的方式实现。

二是一、二级手术、常规治疗、诊查、护理以及超声、病理、内镜检查等技术劳务价值占比高、均质化程度高的项目，建议适当控制各等级医院的价格差距，主要通过各级别医疗机构缓步调增，高级别医疗机构少涨或不涨，低级别医疗机构幅度更大的方式，逐步将价差保持在合理区间。同样以第一款中的情形为例，可将每级价差调整缩小至 10%-15%。

三是 CT、核磁、临床检验等设备物耗为主的项目，建议进一步收紧三级医院和基层医疗机构间的价格差距，主要结合价格治理，各级别医疗机构降价为主，通过高级别医疗机构降幅更大，低级别医疗机构少降或不降的方式，逐步使价格差距在现有水平基础上明显缩小或拉平。同样以第一款中的情形为例，可将每级价差调整缩小至 10%以内。

四是采血、注射等无显著技术差异的项目，经济社会发展相对均衡的地区可探索价格相对趋同，更好支持基层医疗机构健康平稳运行。

13. 立项指南中各种自然腔道内镜治疗或手术应当如何收费？

立项指南所涉及的“内镜检查”主要指经呼吸道、泌尿道、消化道等自然腔道，利用内镜探头进行的检查；立项指南所涉及的“内镜治疗”主要指置入内镜后，通过内镜通道进行的各类治疗；立项指南所涉及的“内镜下手术”主要指“腔镜手术”，即通过有创方式，利用胸腔镜、腹腔镜等在内镜下进行的手术。

立项指南中的“内镜治疗”已在服务产出或价格构成中明确写明不含内镜检查费。医疗机构行相关治疗时，如需使用相关内镜可收取内镜检查费用，如行“气管病变切除”时使用“支气管镜”，可收取“无创气管病变切除费”+“支气管镜检查费”。

针对腔镜手术，为适应腔镜手术已逐步替代大部分开放手术的临床趋势，同

时为避免价格政策诱导选择手术路径。除明确设立加收项的手术类价格项目外，立项指南不区分腔镜手术和开放手术，价格构成已包含胸腔镜、腹腔镜等各类腔镜使用成本，省级或有定价权限的医保部门定价时应结合腔镜使用成本综合确定价格水平。如行“气管病变切除”时使用“胸腔镜”，应直接收取“气管病变切除费”，腔镜辅助操作不再另收费。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第2期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2025年9月29日

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第2期）

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导 （第2期）

1. 中医类价格项目能否在西医科室收费？

可以。立项指南价格项目收费不限制特定学科或科室，符合“使用说明”、“服务产出”、“价格构成”等基本要素的具体规定即可收费。临床实践中，相关科室是否具备资质开展相应诊疗活动，应以卫生行业主管部门规定为准。

2. 中医（灸法、拔罐、推拿）类立项指南中的各类灸法是否可单独收取艾条、艾绒费用等？

不可以。中医（灸法、拔罐、推拿）类立项指南已明确将施灸制品及间隔物制备纳入价格构成，作为基本物耗，不单独收费。

3. 中医推拿治疗不同疾病，且不同疾病的治疗时间均符合收费标准，是否可分别计价收费？

立项指南坚持以服务产出为价格立项原则，中医推拿立项指南按疾病部位进行价格立项，按疾病主诊断所属部位确定收费项目。例如，患者疾病属于“头面部疾病”，但治疗过程中需要推拿头部和肩部的，按“头面部疾病推拿”收费；如患者同时患有腰部疾病和颈部疾病的，需要进行推拿的，可同时收取“腰部疾病推拿”和“颈部疾病推拿”。

4. 手法松解能否同时收取中医推拿费用？

不可以。松解是中医推拿的一种手法，两者服务事项存在交叉。“手法松解费”计价说明中已明确“不与同部位中医推拿同时收费”。

5. 中医灸法、推拿等项目能否按医务人员职称加收？

立项指南对部分手法经验要求较高的针法项目按医务人员技术等级差别定价，副主任医师、主任医师可在主项目基础上加收一定比例费用，其余治疗、手术项目暂未设立技术等级加收项。

6. 中医外治类立项指南是否包含中药饮片？

原则上不包含。不同中药饮片价格差异悬殊，难以直接纳入医疗服务价格构成，可根据医生处方单独收费。已明确纳入立项指南基本物耗的情况除外。

7. 中药贴敷时，多部位贴敷如何收费？

多部位中药贴敷时，面积应按多个部位累积面积计算。例如，三个中药贴敷

面积之和满足中药贴敷（大）面积要求时，可按主项目和加收项累计收费。

8. 患者进行常规针法治疗或特殊针法治疗时，涉及特殊穴位时如何收费？

医疗机构可在收取“常规针法”或“特殊针法”费用的基础上，按穴位收取“特殊穴位针法”费用。例如：在患者5个常规穴位和3个特殊穴位进行针法治疗，应按“常规针法+特殊穴位针法×3”收费。

9. 普通电针是否属于仪器针法？

不属于。仪器针法是通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代实体针具的针刺治疗。普通电针是在使用实体针具基础上，利用电流刺激代替手法刺激，不属于立项指南所称的“仪器针法”，按“常规针法”收费。

10. 部分地区原有“温针灸”如何收费？

“温针灸”在操作技术、服务产出方面与电热针有相似之处，基于立项逻辑一致性的考虑，建议将映射关系调整至“常规针法”，暂按“常规针法”收费，相关易耗品不向患者额外收取费用。

11. 部分地区原有“热敏灸”如何收费？

中医灸法类立项指南编制中，经研究论证，“热敏灸”属于“悬空灸”的一种，因此将其映射到“悬空灸”项目中。各地开展“热敏灸”治疗时，可直接按“悬空灸”项目收费。

12. 医疗机构使用子午流注穴位治疗仪进行针灸对应哪个项目收费？

子午流注穴位治疗仪属于应用仪器产生的电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具完成针法操作的针刺治疗，按“仪器针法”收费。

13. 关节脱位手法整复能否同时收取骨折手法整复费？

可以。患者同时关节脱位和骨折的，医疗机构可据实提供服务，据实分别收取两项费用。

14. 骨折手法整复能否同时收取小夹板固定术费用？

可以。手法整复术价格构成中的“必要时固定”指配合手法整复而使用的固定，如绷带包扎固定，不可单独收费。根据患者病情，行手法整复术后，需再行小夹板固定治疗的，可以收取相应费用。

15. 中医特殊疗法针刀疗法计单位“部位”具体如价何理解？

“针刀（钩活）疗法”的计价单位为“部位”，具体指：头部、颈部、胸部、腰部、腹部、臀部、单侧手部、单侧足部、四肢单个大关节（肩关节、腕关节、肘关节、髋关节、膝关节、踝关节），一次部位多次进针的不叠加收费。

16. 中医针法中的特殊穴位如何理解，双侧特殊穴位应当按一个收还是两个收费？

中医特殊穴位针法按“穴位”计价，指单个特殊穴位。如睛明分左右2个穴位，应按两个计价收费；八髎分左右8个穴位，应按8个计价收费。

17. 中医同时行中医推拿、拔罐、灸法时，是否可以分别收费？

可以。如医务人员分别进行推拿、拔罐等多种治疗时，可以分别收费。但医疗机构运用罐具进行推拿达到治疗目的时，应按中医走罐收费，不得同时收费推拿+拔罐。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第3期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2025 年 10 月 31 日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第3期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导 （第3期）

1. 临床量表评估中的“学科”如何界定？

临床量表评估中的“学科”以医疗机构执业许可证上规定的诊疗科目为准。

2. 临床量表评估中的扩展项“人工智能”能否按评估条数加收？

临床量表评估的主项根据评估条目数量分档收费，主要考虑到随着量表评估条数增加，评估时间也会相应延长，资源消耗也相应增加，应用人工智能的临床量表评估，按照主项的分档标准收费即可。例如，假设某省医保部门制定的“临床量表评估费（自评）”政府指导价为 100 元，乙类加收 30 元，丙类加收 50 元，丁类加收 80 元。人工智能辅助作为扩展项，测评条数为 120 条时，符合丁类加收条数，应收取 180 元。

3. 临床量表评估中的“得出评估结论作为一个完整的计价单位”如何确定？

评估结论指能够满足诊断要求的结论。例如，为诊断患者精神状态，量表评估结果为焦虑伴躁狂，应视作同一个评估结论；再如为诊断患者运动功能和言语功能，通过量表得出的结论，可视为两个评估结论。

4. 置管护理（深静脉/动脉）、引流管护理、造口/瘘护理等项目计价单位为“管·日”“每造口/每瘘口·日”，门诊治疗完成护理操作，能否收取该项目？

可以。上述项目计价单位所称的“管·日”是指：单个管路全天的护理服务，门诊提供该项服务的，也可按此项收费，同一天同一根管路多次护理的，仅按“管·日”收费一次。

5. “精神病人护理”能否与“分级护理”同时收取？

可以。除立项指南有明确规定的情况外，专科护理可以与专项护理、分级护理同时收取。

6. “新生儿护理”“早产儿护理”能否与“压力性损伤护理”同时收费？

可以。“压力性损伤护理”主要是通过减少机械力、促进修复，解决潜在或高风险的缺血性皮肤损伤。“新生儿护理”“早产儿护理”中的皮肤护理主要是通过建立皮肤屏障，帮助未成熟皮肤预防刺激与感染。

7.“重症监护护理”能否收取“气管切开护理”“置管护理（深静脉/动脉）”等其他专项护理？

可以。“重症监护护理”价格构成中包含口腔护理、会阴护理、肛周护理等3项专项护理，不得同时收费，其他专项护理如气管切开护理、置管护理（深静脉/动脉）、气管插管护理等可据实收费。

8. 新生儿护理与重症监护护理能否同时收费？

不可以。“重症监护护理”已设立儿童加收项，新生儿护理指的是为健康新生儿提供的各类照护服务，患病新生儿转入重症监护病房，医疗机构提供的护理服务应按“重症监护护理—儿童（加收）”收费。

9. 患者在普通病房和重症监护病房之间转入转出时，如何收取护理费用？

患者由普通病房转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用，由重症监护病房转入普通病房后，当日可按“日”收取分级护理费用。患者在重症监护病房和普通病房之间转入转出时，当天分级护理不足12小时的，按半天收取。

10. 如危重症、早产儿等医疗机构不允许患者陪护的病房，能否收取“免陪照护费”？

医疗机构出于管理需要，规定危重症、新生儿、早产儿、精神病、干细胞或器官移植等病房不允许患者家属陪护，不得收取“免陪照护费”。

11. 按乙类管理的传染病能否收取“严密隔离护理费”？

医疗机构收取“严密隔离护理费”应以满足价格项目服务产出和价格构成要素为前提，即传染病为国家疾控部门规定的甲、乙类传染病，且医疗机构提供隔离条件满足技术规范所称的单人收治等要求。如患者患有甲、乙类传染病或参照

乙类报告 and 管理的传染病，但医疗机构未能提供符合要求的隔离条件，不得收取“严密隔离护理费”。

12. 重症监护护理价格构成中有“喂食”，能否同时收取“肠内营养输注护理”？

“重症监护护理”价格构成中的“喂食”指生活照护范畴内的喂食，“肠内营养输注护理”属于专项护理，可以与“重症监护护理”同时收取。

13. 医疗机构为防止患者产生压力性损伤，能否同时收取“压力性损伤护理费”和防褥疮气垫（床，褥）材料费用？

不可以。“压力性损伤护理”价格构成明确包含“采用敷料等支撑面减压保护”，防褥疮气垫（床、褥）属于起到减压保护作用的支撑材料，不再单独收费，由医疗机构自主选择是否使用相关产品。

14. 同根管路可同时进行胃肠减压和肠内营养灌注，在对该管路进行护理时，可否分别收取“引流管护理费”和“肠内营养输注护理费”？

不能重复收取。同一管路能够起到胃肠减压、肠内营养灌注等多种不同功能的，不得同时收取“引流管护理”和“肠内营养输注护理”，医疗机构可就高收取其中一项护理费用。

15. 护理类立项指南未明确的“吸痰护理费”“呼吸机吸痰护理费”是否停用？

现阶段可以收费。各地原有“吸痰护理费”“呼吸机吸痰护理费”等价格项目将在一般治疗类立项指南中统一规范，在立项指南印发前，各地可执行原有价格政策。

16. “气管切开护理费”能否与换药同时收费？

不可以。“气管切开护理费”价格构成中已明确包含“更换敷料及固定物，必要时行气道给药”，各地原有换药价格项目不得与“气管切开护理费”同时收费。

17. 护理过程中，护理人员开展的营养风险筛查、呛咳风险评估、生活能力评估等评估能否按临床量表评估收费？

分级护理价格构成中已经包含评估事项，且营养风险筛查、呛咳风险评估、生活能力评估等评估事项属于护理人员观察患者病情、评估护理等级的必要操作，已通过分级护理价格水平体现资源消耗，不再以“临床量表评估”的名义额外收费。

18. “重症监护护理费”单独明确不含监测项目费用，特级护理、Ⅰ级护理等分级护理是否包含监测项目费用？

不包含。立项指南明确界定护理、监测、治疗等医疗服务事项边界，各类护理类价格项目中均不含监测费用，医疗机构提供的监测服务可按项目据实收费。

19. 门诊患者病情需要，需留观一段时间，应如何收费？

如门诊患者在留观期间，医疗机构确实提供相应护理服务，可考虑按病情收取分级护理费用，当天转住院的，不得重复收取分级护理。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第4期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2025年10月31日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第4期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导

（第4期）

1. 血液透析费等价格项目中的血温、血压等监测事项是否限定由设备完成？

针对血液透析所需的监测服务，大部分地区设置了独立的价格项目，少数地区纳入血液透析价格中，不单独立项收费。立项指南已统一将血温、血压等监测服务纳入“血液透析费”价格构成中。相关监测既可以是利用设备提供的医疗服务，也可以是医务人员提供的医疗服务，不绑定任何具体设备。

2. 血液透析费、血液滤过费等项目价格构成中的“穿刺”具体指什么？是否把深静脉穿刺费用纳入价格构成？

“血液透析费”“血液滤过费”等价格项目价格构成中的“穿刺”指“常规静脉穿刺”，不再额外收费，深静脉穿刺及置管将在一般治疗类立项指南中另行规范，具体项目名称以正式发文为准。

3. 腹膜透析延伸服务费中是否包含医生（护士）上门的费用？

“腹膜透析延伸服务费”按“月”收费，已包含一个完整月份中所需的沟通、评估及指导等医学服务，不含医生（护士）上门服务的成本。需要医生（护士）上门提供服务的，可按“上门服务费”的价格政策收费。

4. 腹膜透析操作训练费的封顶线指的是单次培训的封顶，还是全过程中的封顶？

“腹膜透析操作训练费”计价说明中的封顶线指：完整操作训练过程的封顶线，非单次培训的封顶线，即每名患者只能收取一次“腹膜透析操作训练费”。例如：某地操作训练费 p 元，8 小时封顶，即封顶线 $8p$ 元，当患者累计训练 7 小时时，应收费 $7p$ 元；当患者累计训练 10 小时时，应收费 $8p$ 元。

5. 腹膜透析换管费、腹膜透析置管费和腹膜透析导管取出费的关系？

立项指南中的“腹膜透析换管费”指原位换管，即：将置入腹腔内的导管取出，然后按原通路置入新管。如临床操作中发现原通路无法继续置入新管，需在其他位置重新建立通路再置入导管的，按“腹膜透析导管取出费+腹膜透析置管费”收费。

6. 腹膜透析导管取出费和腹膜透析导管感染清创费能否同时收费？

可以。由医疗机构根据临床实际，据实收费。

7. 透析治疗过程中，促红细胞生成素、多糖铁复合物、蔗糖铁注射液等透析注射药物可否收取注射器费用、药品费用？生理盐水是否能够收费？

相关治疗药物可单独收费，立项指南已明确将普通注射器纳入基本物耗，不再单独收费。生理盐水可暂按各地原有收费政策执行。

8.透析管路处理过程中，溶栓药物（尿激酶）、抗凝药物（小分子肝素）是否能够单独收费？

可以。溶栓药物、抗凝药物均属于药品。除立项指南特殊说明的情况外，其余药品均可单独收费。

9. “人工肝治疗”项目如何收费？

“人工肝治疗”通过血浆置换、血浆吸附、连续性肾脏替代治疗等方式清除血液中有毒物质，调节水、电解质及酸碱平衡，减轻肝脏负担，为肝细胞再生或肝移植创造条件。各地原有“人工肝治疗”项目应按医嘱对应实际诊疗方式收费，如：血浆置换、血浆吸附、连续性肾脏替代治疗等据实收费，如同时使用多种治疗模式，可叠加收取。各地医保部门可结合现有收费水平，在相关项目的计价说明中提出费用封顶的政策要求，不再将血浆置换、血浆吸附、连续性肾脏替代治疗等项目组合另设价格项目。

10. 结肠透析如何收费？

“结肠透析”将在一般治疗类立项指南中统一规范，在此之前暂按各地原有收费政策执行。

11. 患者居家腹膜透析治疗时使用的碘伏帽等如何收费？

医疗机构提供碘伏帽、管路等透析耗材，用于患者居家自疗的，医疗机构按零差率销售。相关部门对单独开具碘伏帽、管路等透析耗材有医嘱、处方要求的，医疗机构除收取耗材费用外，可按当地“便民门诊”收费，尽量减轻患者负担。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第5期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2026年2月26日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第5期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导 （第5期）

1. 放射检查类立项指南提出“数字影像处理和上传存储服务”的考虑是什么？

数字影像处理和上传存储服务，即云影像，是放射检查的应尽事项，是检查行为的完整体现。立项指南将其纳入价格构成，并明确相应减收政策旨在促进医疗机构补齐云影像服务供给短板，实现患者可通过便捷方式阅读检查资料、同行可跨地区跨机构调阅检查资料、医保部门可核查已上传的检查资料。

2. 对于公立医疗机构无法提供符合要求的“数字影像处理和上传存储服务”的，具体减收政策应如何执行？

公立医疗机构无法提供符合要求的“数字影像处理和上传存储服务”的，所执行的减收政策按照“部位”减收。例如，X线摄影成像计价单位为“部位·体位”，检查同一部位多个体位时，应减收5元；又如计算机体层成像（CT）平扫

计价单位为“部位”，检查多个部位时，应按部位数量进行减收。

3. 放射检查类立项指南对接落地后，胶片应如何收费？

实体胶片不再打包计入放射检查类项目价格。患者确有需求且知情同意的，医疗机构可按照实际采购价格零差率销售实体胶片。

4. 医疗机构进行多个体位脊柱全长 X 线摄影，能否收取多次影像拼接成像加收费用？

不可以。影像拼接成像指医疗机构完成双下肢或脊柱全长全部影像资料的拼接工作，不与体位挂钩。如医疗机构分别完成双下肢和脊柱全长的影像拼接工作，可收取两次拼接成像费用。

5. 医疗机构利用口腔颌面锥形束 CT（CBCT）技术检查骨骼、耳乳突、鼻咽部等口腔以外部位，能否收取口腔曲面体层成像费用？

不可以。现阶段口腔颌面锥形束 CT（CBCT）仅限口腔颌面使用收费，其他部位不得按此收费，应按“计算机体层成像（CT）平扫”收费。

6. X 线摄影成像（牙片）的计价说明中“以两个牙位为一个部位”，具体指什么？

牙片计价收费时，切牙、前磨牙和磨牙，以两个牙位为一个部位，具体指相邻的两颗牙齿视作一个部位；尖牙，以单牙位为一个部位。

7. 患者单侧乳腺接受两个体位（正位+斜位）的 X 线摄影的，医疗机构能否收取两次费用？

不可以。“X 线摄影成像（乳腺）”计价单位为单侧，不区分体位，临床操作中单侧乳腺 X 线检查涉及多个体位时按一次收费。

8. 患者同时接受颅脑 CT 平扫和颅内动脉造影成像的，医疗机构能否分别计费？

应根据检查目的判断是否分别收费。如医疗机构以检查颅内动脉为目的，进行颅内动脉造影成像，应收取计算机体层（CT）造影成像（血管）费用，不得重复收取 CT 平扫费用。如医疗机构同时检查颅脑组织结构和颅内动脉，且确实开展两次扫描，可分别收取 CT 平扫和计算机体层（CT）造影成像（血管）。收费次数应与实际扫描检查次数吻合。

9. 立项指南使用说明中未明确的血管应如何收费？

医疗机构应严格按照使用说明中界定的血管范畴计价收费。立项指南使用说明中未明确说明的各类旁支或分支血管检查，应结合临床实际，参照对应的主干血管收费。例如，冠状动脉包含左冠状动脉、右冠状动脉，根据需要检查左右冠状动脉，应按冠状动脉收费；又如肾动脉属于腹主动脉分支血管，检查肾动脉时，应按腹主动脉收费。

10. 立项指南使用说明中未明确的部位应如何收费？

医疗机构应严格按照使用说明中界定的部位范畴计价收费。若所扫器官组织属于立项指南所列部位的结构组成，如行副鼻窦 CT 扫描，副鼻窦属于鼻咽部的组成部分，应直接按鼻咽部收费；如果所扫描器官组织确无法对应到立项指南所列部位，可按其他收费，但不得分解组织器官收费。

医疗机构可在医嘱中体现部位扫描名称，如一名患者同时行胸部 CT 和上腹部 CT 检查，可按照“计算机体层成像（CT）平扫”×2 的方式计费，可自行在收费单据中备注具体部位名称，方便患者理解及日后管理。

11.患者接受单侧上肢多个部位（肱骨、尺骨、肘关节、手部及腕关节）的X线摄影成像、计算机体层成像（CT），医疗机构能否收取多个部位费用？

不可以。立项指南已明确单侧上肢、单侧下肢为一个计价部位，涵盖单侧上肢、单侧下肢的完整检查。医疗机构同时检查上肢的肱骨、尺骨、肘关节等多个部位时，不得拆分收费，应按照单侧上肢收取一次费用。如医务人员评估认为仅检查肱骨单个部位即可支持诊断，亦可按“单侧上肢”收取检查费用，后续如因初始检查范围不足，需追加检查首次检查部位时，不得重复收取检查费用。

12.患者眼部接受X线或计算机体层成像（CT）扫描检查时，同时检查眼眶和视神经孔，医疗机构能否收取3个部位费用？

不可以。眼眶和视神经孔属于眼部精细解剖结构，医疗机构检查时应根据患者病情及临床规范决定是否同时检查眼眶和视神经孔，但不得拆分为三个部位重复收费。

13.医疗机构通过计算机体层（CT）平扫进行骨密度测定，能否同时收取计算机体层（CT）平扫+骨密度测定费用？

不可以。骨骼肌肉系统立项指南已单独设立“骨密度测定费”价格项目，涵盖通过各种方法测量骨骼中的矿物质含量，医疗机构测定骨密度时，应收取“骨密度测定费”，不得重复收取“计算机体层（CT）平扫”。

14.患者同时接受腹部平扫、腹部增强和腹主动脉CTA检查的，医疗机构应如何计价收费？

分别进行腹部平扫、增强和腹主动脉CTA检查可同时收取“计算机体层成像（CT）平扫”+“计算机体层成像（CT）增强”+“计算机体层（CT）造影成像（血管）”。医疗机构收费次数应与实际扫描检查次数吻合。

15.医疗机构通过图像重建,实现薄层效果,能否收取计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描加收?

不可以。立项指南明确薄层扫描指通过计算机体层成像(CT)扫描,获取标称层厚 $<2\text{mm}$ 的图像,标称层厚指:医学影像扫描前,由操作技师预设设备采集的原始数据层的断层厚度,通俗理解为“扫描原始精度”。如扫描标称层厚 $>2\text{mm}$,后续通过相关软件处理和重建后,得到层厚 $<2\text{mm}$ 的图像,不能按薄层扫描加收。

16.患者同时接受磁共振平扫和磁共振水成像检查的,医疗机构能否收取两次费用?

不可以。磁共振平扫和磁共振水成像检查是在一次检查过程中,使用同一台磁共振检查仪器,通过多个不同的“扫描序列”完成的检查,且磁共振水成像不属于特殊成像范畴,与磁共振平扫同时开展时,应按磁共振平扫收费一次。如医疗机构分别进行两次检查,可据实收取两次费用,收费次数应与实际扫描检查次数吻合。

17.磁共振检查中除使用说明中已经明确的“特殊方式成像”外,医疗机构能否自行增加其他成像方式?

不可以。除立项指南使用说明已明确的“特殊方式成像”外,医疗机构不得自行扩展特殊成像方式范围。

18.磁共振特殊方式成像中包含磁共振波谱分析,患者同时接受氢谱、磷谱的波谱分析检查,医疗机构能否叠加收费?

不可以。氢谱与磷谱是磁共振波谱成像中依据检测原子核的不同而划分的两种技术手段,氢谱主要用于观察神经元标志物等脑内代谢物,磷谱主要用于观察细胞能量活动,氢谱与磷谱属于磁共振波谱成像的具体技术应用,单次检查如同

时采用氢谱与磷谱，应按“磁共振波谱分析”收取一次加收项费用，不重复收费。

19.患者接受头颅磁共振（MR）平扫成像（血管）检查，医疗机构能否收取“平扫+血管”费用？

不可以，医疗机构应收取磁共振（MR）平扫成像（血管）。如医疗机构先进行磁共振（MR）平扫检查颅脑结构，后进行磁共振（MR）平扫成像（血管）检查颅内血管结构，实际扫描检查两次，可据实收取两次费用，收费次数应与实际扫描检查次数吻合。

20. 患者同时接受磁共振平扫和弥散成像检查，医疗机构应如何计价收费？

立项指南明确磁共振弥散成像属于一种特殊方式成像，设立为加收项。医疗机构同时开展磁共振平扫和弥散成像检查时，应收取主项目及特殊方式成像（加收）费用。例如，某地磁共振成像价格水平 P 元，特殊方式成像按 30%加收，如医疗机构单独行弥散成像时，应收取 $P+0.3P$ 元；如医疗机构分别进行磁共振平扫和弥散成像检查两次扫描，应收取 $P+P+0.3P$ 元。

21. 患者同时接受左右髋关节磁共振（MR）检查，医疗机构能否按两个部位收取费用？

不可以。立项指南明确磁共振检查髋关节不区分左右侧。主要是考虑到临床实际检查中，检查髋关节通常需要使用扫描范围较大的线圈双侧对称扫描，以便左右对比观察。

22.放射检查类立项指南落地后，部分地区原有医学影像快速诊疗分析等价格项目如何收费？

应在放射检查中停用此类价格项目。放射检查类立项指南已将医学影像快速诊疗等人工智能辅助诊断技术作为扩展项，采用人工智能辅助诊断技术的，可按相应价格项目扩展项收取，不与主项目同时收费。

23.如患者首日磁共振平扫后发现异常，次日再次进行磁共振平扫-特殊方式成像，次日能否按磁共振（MR）平扫-特殊方式成像（加收）计费？

可以。如患者因病情需要进行进一步检查，可正常收取检查费用。例如，某地磁共振价格水平为 P 元，特殊方式成像加收 30%，次日患者进行磁共振弥散成像时，应收取“磁共振（MR）平扫”+“磁共振（MR）平扫-特殊方式成像（加收）”费用，检查费用为 $P+0.3P$ 元。

24.患者同一部位接受放射性核素平面显像（静态）+（动态）检查的，医疗机构能否同时收取两项费用？

动态检查过程中同步采集到的图像信息已包含静态检查的图像信息。如该信息已能满足诊断需要，不得重复收取放射性核素平面显像（静态）费用，如该信息不能满足诊断需要，医疗机构多做一次放射性核素平面显像（静态），可按实际收取费用。收费次数应与实际检查次数吻合。

25. 医疗机构自制的 PET-CT 对比剂，没有药字号，应如何计价收费？

医疗机构院内自制的对比剂应在行业主管部门审批同意后，在本院内向患者收费。

26.患者同时接受甲状腺有效半衰期测定、甲状腺激素抑制显像、促甲状腺激素兴奋显像等检查时，医疗机构能否按检查次数收取甲状腺摄碘

131 试验费用？

可以。甲状腺摄碘 131 试验计价单位中的“次”指完成一次完整独立试验检

查过程，如医疗机构完成多个实验检查的，可按次数计价收费。

27. 医疗机构利用核素标记法同时测定血容量和红细胞寿命时，应如何计价收费？

应收取两次“核素标记测定费”。“核素标记测定费”计价单位中的“项”指完成一次完整独立试验检查过程，如医疗机构完成多个实验检查的，可按次数计价收费。

28. 患者同时接受介入肾图和肾图检查时，医疗机构能否同时收取肾图和干预肾图加收项？

可以。同时开展肾图和介入肾图检查时，应收取“肾图”+“肾图”+“肾图-干预肾图加收”。收费次数应与实际检查次数吻合。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第6期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2026年2月26日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第6期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导

（第6期）

1. 医疗机构开展常规彩超检查时，根据需要对患者同一部位进行不同体位检查的，能否按体位数量计价收费？

彩色多普勒超声检查（常规）计价单位为部位，不区分体位，医疗机构开展同一部位不同体位的超声检查应按一次收费。

2. 临床科室自行配置超声设备开展超声检查，能否收取超声检查费用？

医疗服务价格项目不限制特定学科或科室。临床实践中，相关科室是否具备资质开展相应诊疗活动，应以卫生行业主管部门规定为准。

3. 医疗机构利用同台设备在床旁开展彩色多普勒超声检查（常规）和彩色多普勒超声检查（血管），能否收取多次床旁加收费用？

医疗机构利用同台设备单次完成多项床旁检查的，应按一次床旁加收计价收费。

4. 医疗机构开展超声检查时，单次检查多个部位的体表软组织，能否分别计价收费？

超声检查立项指南使用说明中已明确体表软组织作为一个完整计价部位，医疗机构同时检查不同部位的体表软组织，应收取一次费用。

5. 医疗机构开展超声检查时，单次检查多个部位的周围神经，能否分别计价收费？

超声检查立项指南使用说明中已明确周围神经作为一个完整计价部位，医疗机构同时检查不同部位的周围神经，应收取一次费用。

6. 医疗机构开展超声检查时，单次检查多个部位的浅表淋巴结（含颈部、腋窝、腹腔、腹股沟）能否分别收费？

超声检查立项指南使用说明中已明确浅表淋巴结作为一个完整计价部位，医疗机构同时检查不同部位的浅表淋巴结，应收取一次费用。

7. 医疗机构单次颅内血管检查同时涉及发泡试验、CO₂试验两项试验，应如何收费？

医疗机构同时开展发泡试验和 CO₂吸入试验的，可收取多普勒检查（颅内血管）+特殊方式检查（加收）×2。

8. 医疗机构进行膀胱残余尿量、胆道收缩功能等对比检查时，应如何收费？

医疗机构可根据实际检查方式，在对比检查前后各收费一次。如利用 B 超进行膀胱残余尿量检查的，可收取“B 型超声检查费”×2。

9.医疗机构能否同时收取彩色多普勒超声检查（胎儿）和扩展项“胎儿血流动力学检查”？

医疗机构结合临床实际，确有必要分别提供相应服务的，可依规据实收费。

10. 医疗机构具体应如何收取可疑胎儿产前诊断费用？

医疗机构能否收取可疑胎儿产前诊断费，应根据检查人员资质和检查内容判断。根据技术规范要求，可疑胎儿产前诊断应由具备资质的产前诊断机构的超声诊断人员完成，服务内容除完成胎儿彩色多普勒超声系统性结构畸形筛查内容外，还包含对可疑异常结构进行进一步详细扫查和评估。

11.医疗机构开展胎儿三维/四维超声重建成像，能否收取彩色多普勒超声检查（常规）-立体成像（加收）费用？

彩色多普勒超声检查（胎儿系统性筛查）已涵盖基本成像需求，不再另行收取彩色多普勒超声检查（常规）—立体成像（加收）费用。

12. 胃肠道造影中使用五谷造影剂等非药品类对比剂，能否单独收费？

立项指南使用说明已明确，非药品类对比剂纳入基本物质资源消耗，不另行收费。

13. “彩色多普勒超声检查（弹性成像）”计价单位为“器官”，应如何理解？

彩色多普勒超声检查（弹性成像）计价单位“器官”指：病变组织或病灶所在的器官，不应按病灶数量或扫描切面拆分收费。

14.医疗机构能否同时收取“彩色多普勒超声检查（弹性成像）”和“彩色多普勒超声检查（常规）”？

应根据临床实际提供的医疗服务确定。医疗机构单独开展“彩色多普勒超声检查（弹性成像）”的，彩色多普勒超声检查（常规）作为必要步骤，不额外收费。医疗机构进行“彩色多普勒超声检查（常规）”后，临床诊断确有必要进行弹性成像检查的，可在收取“彩色多普勒超声检查（常规）”后再收取“彩色多普勒超声检查（弹性成像）”。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第7期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2026年2月26日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第7期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导 （第7期）

1. 医疗机构提供体检服务的，应如何收费？

医疗机构提供基础常规体检服务的，可按门诊诊查费收费；医疗机构提供套餐式体检服务的，收取体检套餐费用，不再收取门诊诊查费。

2. 基层医疗机构如何收取一般诊疗费和门诊诊查费？

同一基层医疗机构不应同时出现门诊诊查费和一般诊疗费两种不同收费方式，具体采取哪种方式由省级医保局或具有价格权限的地市级人民政府统一明确。

3. 患者复诊或在换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗等长疗程治疗过程中，医疗机构能否多次收取诊查费？

挂号有效期内不应重复收取诊查费，挂号有效期应以当地价格政策为准，如当地已明确“一号管三天”等价格政策，则三天内不得重复收取诊查费。

4. 医疗机构提供非免疫规划疫苗接种服务的，能否收取诊查费？

非免疫规划疫苗的接种服务费属于行政事业性收费，接种单位接种非免疫规划疫苗，除收取疫苗费用外，可依规收取接种服务费，但不应收取门诊诊查费。

5. 医疗机构能否同时收取急诊诊查费（留观）和急诊诊查费（普通）？

患者急诊就诊时，医疗机构可收取急诊诊查费（普通），患者因病情需要留观的，可收取急诊诊查费（留观），确有必要同时发生的，医疗机构可依规据实收费。

6. 会诊费（院内）计价单位为“学科·次”，多个学科参与会诊时，医疗机构如何收费？

医疗机构可按实际邀请参与会诊的学科数量收取会诊费。例如，某地会诊费为P元/学科·次，患者在心内科就诊，心内科邀请胸外科、病理科、肾内科会诊，可收取3*P元。需说明的是，考虑到多学科会诊主要针对疑难杂症的诊断和治疗服务，现阶段立项指南明确，药学、护理暂不作为单独学科计价收费。

7. 营养科、影像科、病理科等参加会诊，医疗机构能否收取会诊费？

医疗机构可按学科数量依规据实收取会诊费。

8. 患者携带外院影像资料就诊时，医疗机构如何收费？

门诊诊查费价格构成中包含阅读检查检验结果，患者携带检查检验资料就医的，医疗机构收取门诊诊查费，不得额外收费。如需要相应检查检验科室共同参与进行判读的，医疗机构可在收取诊查费的基础上，据实收取院内会诊费。

9. 单次诊疗过程中，医疗机构能否同时收取多学科诊疗费与会诊费？

多学科诊疗收费应符合国家卫生健康主管部门准许开展条件，且满足立项指南所要求的医师级别和诊疗时间，按次收费，不与会诊费同时收取。

10. 同一天内医疗机构为同一名患者进行多次远程会诊，能否多次收费？

会诊费（远程会诊）计价单位为“日”，每名患者一天收费一次，与具体会诊次数无关。

11. 医疗机构能否同时收取会诊费（远程会诊）与互联网诊查费？

医疗机构应依规据实收费。远程会诊和互联网诊查费发起主体和应用场景有所差异，远程会诊由医疗机构发起，院际间通过视频实时、同步交互的方式开展；互联网诊查由患者自主发起，在互联网诊疗平台上开展。

12. 医疗机构开展远程会诊，应如何收费？

会诊费（远程会诊）由就诊地医疗机构向患者收费，价格水平按受邀方医疗机构所在地价格标准执行。例如，A 院邀请 B 院医疗机构进行远程会诊，A 院远程会诊价格水平为 P1 元，B 院远程会诊价格水平为 P2 元，收费时应由 A 院向患者收取 P2 元，具体收益回报分成由两院自行确定。

13. 医疗机构邀请外地专家来本院坐诊，应如何收费？

专家异地坐诊的，执行邀请方医疗机构所在地的价格政策，按相应职称级别收取门诊诊查费。

14. 医疗机构邀请外地专家前来本院会诊的，应如何收费？

按照“上门服务费+会诊费（院外）”的方式收费，上门服务费按受邀地医疗机构自主制定的收费标准执行，会诊费按就诊医疗机构所在地价格政策执行。

15. 医疗机构开展互联网复诊，能否按医师级别收费？

现阶段互联网复诊费不区分医师级别，不同级别医务人员提供互联网复诊服务时，应按同一价格标准收费。

16. 医疗机构在救护车转运患者过程中，提供心电监护，能否收取远程监测费？

远程监测计价说明已明确，能够提供远程实时监测、数据实时传输的监测服务的，医疗机构可收取远程监测费。医疗机构在救护车转运过程中，利用监护仪提供心电监测服务的，仅具有数据存储功能的，应收取心电监测费。

17. 医疗机构为患者提供动态心电图（Holter 检测），进行居家监测时，能否收取远程监测费？

医疗机构开展动态心电图检查的，可收取动态心电图检查费，不应收取远程监测费。

18. 床位费（单人间）的部分床位能否执行政府指导价？

床位费单人间执行市场调节价，由医疗机构按照合法公平、诚实信用、质价相符的原则合理定价，与医院等级、专业地位、功能定位相匹配。未达到立项指南所列服务产出要求的单人间床位，医疗机构收取床位费从严把握，或暂时按原政府指导价执行。

19.新生儿在重症监护病房接受治疗的情况下，医疗机构能否同时收取床位费（重症监护）和新生儿暖箱费？

新生儿暖箱费本质属于一类特殊床位费，新生儿入住重症监护病区的，医疗机构可收取床位费（重症监护），不同时收取新生儿暖箱费。

20.新生儿出生 28 天后，确需进一步暖箱治疗的情况下，医疗机构能否收取新生儿暖箱费？

新生儿暖箱费服务产出已明确，收费范围不限于新生儿、早产儿，婴儿确有必要在暖箱接受治疗的，可按此收费。

21. 医疗机构设有百级、千级、万级层流洁净标准床位的，如何收取床位费？

医疗机构相应病房满足 I 级洁净用房相关要求的，可收取床位费（层流洁净）；不满足相关要求的病房，按普通床位费收取。

22. 在患者当天随入随出的情况下，医疗机构如何收取床位费？

患者当天随入随出的，可收取当日床位费。

23. 医疗机构在非病房空间增加床位，能否收取床位费？

医疗机构是否可在非病房空间加床应以卫生行业主管部门相关规定为准。如特殊情况下，卫生行业主管部门允许在非病房空间增加床位，医疗机构可按照床位费（多人间）—临时床位收费。

24. 医疗机构在病房内增加床位，应如何收费？

在相关部门允许增加床位的情况下，医疗机构可按照加床后病房内实际床位

数收费，如两人间病房增加 1 张床位后，所在病房应执行床位费（三人间）收费标准。

25. 床位费（重症监护）是否限定 ICU 收取？

如医疗机构已在相应病房标志中体现重症监护，可收取床位费（重症监护）。

26. 如急诊留观床位符合三人间标准，医疗机构应收取床位费（急诊留观），还是床位费（三人间）？

立项指南已单独设立床位费（急诊留观），急诊留观患者需要床位的，可收取床位费（急诊留观）。

27. 医疗机构能否同时收取救护车转运费和上门服务费？

救护车转运费已包含相应交通成本和出诊费用，不应收取上门服务费。

28. 医疗机构为非急救患者提供转运服务，应如何收费？

非急救医疗转运有别于急救转运，是充分运用公共医疗资源满足群众多元化需求的有益补充，立项指南支持各地引导医疗机构参照“救护车转运费”，合理制定非急救转运收费水平。

29. 病历复制费能否作为医疗服务价格项目收费？

病历复制费不属于医疗服务价格项目，不纳入医疗服务价格项目范围。根据《医疗纠纷预防和处理条例》《医疗机构病历管理规定（2013 年版）》等文件规定，医疗机构应患者要求复制病历资料，可收取工本费，收费标准应当公开。

30. 医疗机构提供家庭病床建床服务，应如何收取家庭病床建床费？

家庭病床建床费计价单位“次”指：完成家庭病床改造所需的完整周期，如需进行多次改造，医疗机构应按一次计价收费。

31. 医疗机构开展院内抢救时，能否收取心脏电除颤和气管插管费用？

院内抢救费服务产出和价格构成不含心脏电除颤、气管插管等心肺复苏方式，医疗机构抢救过程中可依规据实收费。

32. 医疗机构实施心肺复苏术后，患者未能恢复自主循环和呼吸，能否收取心肺复苏费？

医疗机构按规范要求提供相应医疗服务的，可依规据实收费。

33. 医疗机构收取安宁疗护费时，能否同时收取免陪照护费？

安宁疗护价格构成中已包括沟通陪伴所需的人力资源和基本物质资源消耗，医疗机构收取安宁疗护后，不应收取免陪照护费。

34. 传染病专科医院未满足单间收治要求，能否收取严密隔离护理？

严密隔离护理计价说明明确，护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范（2023年版）》，技术规范要求严密隔离护理需满足患者单间收治，未达到技术规范所列条件的，不应按“严密隔离护理”计价收费。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第8期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2026年2月26日

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第8期）

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导

（第8期）

1. 医疗机构开展放疗模拟定位中的 MR、PET-CT 等特殊影像模拟定位时，能否同时收取 MR、PET-CT 检查费？

MR、PET-CT 模拟定位价格构成已包含相应 MR、PET-CT 检查过程，不应额外收取检查费用。

2. 医疗机构利用具备适形、调强、立体定向等多种治疗模式的设备开展治疗的，如何计价收费？

医疗机构利用多种治疗模式的放疗设备开展治疗时，可按当次所用的治疗模式，依规据实收费；同时采用多种治疗模式的，医疗机构实际收费时，可按收费标准最高的医疗服务价格项目计费，不叠加计费。

3. 医疗机构制定放疗计划时，涉及患者不同部位的，能否按部位收取放疗计划制定费？

放疗计划制定的计价单位“次”指：一次完整的放疗计划。同次放疗计划制定涉及不同部位的，应按一次放疗计划制定计价收费。

4. 医疗机构开展康复训练时，能否收取其他物理治疗项目费用？

医疗机构根据临床实际，同时开展康复训练和物理治疗的，可依规据实收费。需说明的是，意识功能训练主要依赖物理治疗仪器开展，已涵盖声、光、电等各种感觉刺激费用，如已收取意识功能训练费，不应同时收取相关物理治疗价格项目费用。

5. 未明确区分团体或个体的康复训练，医疗机构能否进行团体训练？

医疗机构按卫生行业主管部门有关要求开展医疗服务的，可依规据实收费。

6. 医疗机构通过多种检查方式（徒手肌力检查、关节活动度检查等）得出运动功能障碍诊断的，能否按项收取运动功能检查费？

运动功能检查计价单位“次”指：检查并得出结论的完整过程。医疗机构通过各种方式，得出运动功能障碍结论的，应按一次检查计价收费。

7. 医疗机构同时去除干细胞中多种成分，如何计费？

干细胞成分去除费计价单位为“成分”，医疗机构可按实际去除的成分种类收费。例如，一次治疗中同时去除红细胞与血浆，可收取两次费用。

8. 医疗机构如何处理血液辐照费和辐照血收费的关系？

如血站、血库提供的血制品已经过放射辐照处理，医疗机构可收取血制品相关费用。如血站、血库提供的血制品未经过放射辐照处理，由医疗机构自行辐照的，医疗机构可按照人•次收取血液辐照费。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第9期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2026年2月26日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第9期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导 （第9期）

1. 医疗机构开展心理治疗（家庭）、康复治疗（家庭）的，如何收费？

心理治疗（家庭）、康复治疗（家庭）的计价单位为“小时”和“半小时”，医疗机构可按每个家庭实际治疗时间计价收费。

2. 医疗机构同时为多名患者开展心理治疗（团体）的，应如何收费？

多名患者同时接受团体心理治疗时，医疗机构可按治疗人数分别计价收费。

3. 医疗机构为患者提供个体、团体等多种心理治疗的，能否分别计费？

医疗机构为患者提供心理治疗（个体）和心理治疗（团体）等不同形式心理治疗的，可依规据实收费。

4. 精神康复治疗中所称的“专业人员”，医保部门是否有具体资质要求？

精神康复治疗从业人员相关资质要求，以卫生行业主管部门有关规定为准。

5. 医疗机构开展心理治疗、康复治疗的，能否按医务人员职称加收？

患者就诊时，医疗机构已按医务人员职称收取相应门诊诊查费，收取治疗费用时不应再按医务人员职称加收。

6. 医疗机构通过线上实时视频交互手段提供心理咨询的，能否收取心理咨询费？

立项指南使用说明已明确，心理治疗指线下或运用线上实时视频交互手段实现的治疗，录音录像等不得按此收费。

7. 医疗机构收取精神科监护时，能否同时收取精神康复治疗等其他费用？

医疗机构在符合行业规范的情况下，向精神科监护期间的患者提供医疗服务的，可依规据实收费。

8. 医疗机构为非重性精神疾病患者提供的监护事项，如何收费？

护理类立项指南已设立精神病人护理，医疗机构提供相应医疗服务的，可依规据实收费。

9. 医疗机构能否保留精神病首诊或门诊诊查费中的精神科加收？

门诊诊查费不区分学科，医疗机构为患者提供精神病诊查的，可按相应职称

级别收取门诊诊查费。

读要网会员内部资料仅供参考

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 10 期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2026 年 2 月 26 日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 10 期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导

（第 10 期）

1. 医疗机构能否保留岩盐气溶胶治疗价格项目？

岩盐气溶胶治疗属于雾化吸入治疗的具体方式，医疗机构可按雾化吸入治疗收费。

2. 医疗机构使用多种能量源进行支气管镜特殊治疗的，能否叠加计费？

医疗机构使用多种能量源进行支气管镜特殊治疗，应按一次治疗计价收费。

3. 医疗机构开展肺段、肺叶、全肺切除的，能否收取淋巴清扫费？

肺段、肺叶、全肺切除的服务产出与价格构成中不含淋巴清扫，手术过程中确有必要进行淋巴清扫的，医疗机构可据实收取胸腔淋巴清扫费。

4. 医疗机构开展皮肤微生物检查的，能否收取检验费？

皮肤微生物检查费价格构成中已包含取材、检测、出具报告全流程所需的人力资源和基本物质资源消耗，医疗机构不再另收取检验费。

5. 医疗机构进行皮肤镜检查，涉及多个视野，能否收取2次费用？

皮肤镜检查计价单位“次”指：开展检查并出具结论的完整过程。医疗机构单次皮肤镜检查，涉及多个视野的，应按一次检查计价收费。

6. 医疗机构收取烧伤抢救费时，能否同时收取院内抢救费？

烧伤抢救费属于抢救费的特殊场景，不另收取其他类别抢救费。

7. 医疗机构点痣时，应如何收费？

医疗机构点痣可根据具体方式选择相应价格项目收费，如医疗机构选择化学方式点痣，可收取皮损治疗费（常规）；如医疗机构选择激光等方式点痣，可收取皮损治疗费（特殊）；如医疗机构选择切除、剜除等方式去除痣以及周边组织，可收取浅表肿物去除费。

8. 体表系统中的面积指肿物面积还是切除皮肤的面积？

体表系统立项指南中的“面积”指肿物的实际面积。

9. 外科手术中，患者自愿进行美容减张缝合的，医疗机构能否收费？

在患者知情同意情况下，医院具备美容整形诊疗资质的，可依规据实收费。

10. 皮肤生理指标检查除立项指南已规定的指标外，其他指标是否能够收费？

现阶段皮肤生理指标检查已涵盖技术规范列明的各类指标。其他未列明的指标，可由医疗机构按“现有项目兼容”方式，向本地区医疗保障部门报告后按照对应价格项目执行。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 11 期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2026 年 5 月 7 日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第 11 期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导

（第 11 期）

1. 同台手术中，医疗机构采取多种麻醉方式，开展联合麻醉能否同时收费？

医疗机构根据临床需要确有必要开展联合麻醉的，可依规据实收费，具体计费方式以属地医保部门价格政策为准。

2. 医疗机构能否同时收取“麻醉监护下镇静”与“局部麻醉”？

麻醉监护下镇静的服务产出为“使病人处于清醒镇静状态，为有创操作或检查创造条件”，局部麻醉服务产出为“暂时阻断神经传导，产生局麻效果”。医疗机构确有必要同时开展麻醉监护下镇静和局部麻醉的，可依规据实收费，具体计费方式以属地医保部门价格政策为准。

3. 医疗机构通过药物吸入等方式进行镇静，能否收取“麻醉监护下镇静”？

麻醉监护下镇静中的“药物注入”包括但不限于注射、吸入等各类方式，医疗机构根据临床规范开展麻醉监护下镇静的，可依规据实收费。

4. 医疗机构在麻醉监测过程中，开展动脉穿刺置管术、中心静脉穿刺置管术等，能否单独收费？

麻醉类立项指南价格构成中的“静脉穿刺”指麻醉过程中的必要穿刺环节，医疗机构开展动脉穿刺置管、中心静脉穿刺置管等独立于麻醉操作的穿刺时，可依规据实收费。

5. 医疗机构开展麻醉时，能否同时收取有创/无创呼吸机辅助通气？

麻醉类立项指南价格构成中已包含机械通气，医疗机构不应额外收取一般治疗类立项指南中的呼吸机辅助呼吸费（无创/有创）。

6. 麻醉类立项指南使用说明基本物耗中包含钠石灰，医疗机构能否单独收取钙石灰费用？

钠石灰、钙石灰均为二氧化碳吸收剂的同类产品，均应纳入基本物耗考虑，医疗机构不应单独收取相关费用。考虑到绝大多数钠石灰、钙石灰均按耗材注册备案，且已明确作为基本物耗纳入价格构成，建议各地在计价收费时，不区分药品或耗材注册备案的钠石灰、钙石灰，均不应单独收费。

7. 医疗机构针对两个及以上部位使用神经阻滞麻醉，能否多次计费？

局部麻醉费（神经阻滞麻醉）计价单位为次，单次以2小时为基础计费，超过2小时每小时加收，不按部位计费。

8. 患者由分娩镇痛下的自然分娩转为剖腹产，医疗机构提供椎管内麻醉或全身麻醉，能否收取相关麻醉费用？

娩镇痛、椎管内麻醉或全身麻醉的服务目标、麻醉流程和应用场景有较大区别，临床诊疗确有需要的，可按计价单位分别收取分娩镇痛和椎管内麻醉或全身麻醉。

9. 医疗机构开展口腔、眼科等治疗或手术时，应收取“局部麻醉费(局部浸润麻醉)”还是“局部麻醉费(神经阻滞麻醉)”？

医疗机构应根据治疗及手术位置、目的判断具体麻醉类型，据实按相应价格项目收费。如麻醉药物直接注射在黏膜下或周围组织内，作用于局部神经末梢，应按“局部浸润麻醉”收费；如药物注射在神经主干附近，阻断神经传导，应按“神经阻滞麻醉”收费。

10. 麻醉类价格项目按时长计价收费，医疗机构如何确定麻醉结束时间节点？

医疗机构应结合麻醉监测记录确定麻醉结束时间，麻醉计价结束时间应与监测系统结束时间保持一致。

11. 麻醉过程中，医疗机构开展血气分析等检验项目，能否单独收费？

麻醉类价格项目的价格构成中不包含检验成本，医疗机构确有必要开展检验

的，可按相应价格项目依规据实收费。

12. 麻醉项目价格构成中包含术中各类监测成本，具体包含哪些监测项目？

麻醉类立项指南中的“监测”指由麻醉医生实施，与麻醉操作直接相关的各类监测项目，不包括其他类别立项指南中设立的、用于提高治疗或手术精确度的监测类价格项目，例如神经系统相关立项指南中的“颅内压监测费”“神经电生理定位监测费”等，医疗机构开展此类监测服务，可按相应价格项目依规据实收费。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第12期）

发布机构：国家医疗保障局

发布时间：2026年5月7日

[医疗服务价格项目立项指南解读辅导（第12期）](#)

编者按：为推进各地医保部门更好对接落地医疗服务价格项目立项指南（以下简称“立项指南”），统一规范价格项目立项和定价基本思路，现就各方关切的普遍问题，提出立项指南解读辅导口径，供各地医保部门学习参考。立项指南解读辅导是立项指南层面的解释解读口径，不直接作为医保基金稽核依据。各地医保部门可参考解读辅导，围绕本地区医疗服务价格立项、定价、映射关系等作出解释解读，医疗机构收费以本地区医保部门出台的医疗服务价格政策为准。

医疗服务价格项目立项指南解读辅导

（第12期）

1. 医疗机构开展刮宫、人工流产时，能否同时收取宫颈内口检查费？

宫颈内口检查属于刮宫、人工流产的必要步骤，医疗机构不应同时收费。

2. 医疗机构开展妇科手术时，能否同时收取子宫动脉结扎费？

医疗机构应根据子宫动脉结扎是否属于手术的必要步骤，确定是否收费。如子宫动脉结扎属于妇科手术（如子宫全切术）的必要步骤，则医疗机构不应同时收取子宫动脉结扎费；如不属于手术的必要步骤，则医疗机构可同时收取手术费用和子宫动脉结扎费。

3. 妇科立项指南中的阴蒂整形费、阴唇整形费和美容整形立项指南中的阴蒂美容整形费、阴唇美容整形费，如何区分和收费？

如属于基本医疗服务，医疗机构可按妇科类价格项目收取；如患者有美容整

形需求，在患者知情同意且医院符合美容整形诊疗条件的，医疗机构可按美容整形类价格项目收取。

4. 单次子宫活检中，医疗机构同时取子宫内膜、子宫颈、子宫颈内膜三个部位的样本，能否分别计费？

子宫活检费计价单位“次”指一次完整的子宫活检取样过程，取样过程中涉及多个部位的，应按一次收费。

5. 医疗机构能否同时收取宫内节育器放置费和宫内节育器取出费？

因临床需要，医疗机构确需更换节育器的，医疗机构可依规据实收费。

6. 医疗机构为男性患者开展盆底相关手术，能否收取相应费用？

医疗机构根据患者需要，确有必要进行盆底重建或盆腔肿瘤切除等盆底手术的，可依规据实收取相应费用。

7. 医疗机构在同一治疗过程中针对同部位开展臭氧、红外线等不同特殊治疗的，能否收取两次妇科特殊治疗费用？

妇科特殊治疗费计价单位为“部位”，医疗机构在一次治疗过程中利用多种方式针对同部位开展特殊治疗的，根据以服务产出为导向的立项原则，应按1次计价收费。

8. 医疗机构针对同部位开展常规治疗或特殊治疗，能否同时收取常规治疗和特殊治疗费？

医疗机构针对同部位同一疾病开展常规治疗和特殊治疗的，根据以服务产出

为导向的立项原则，可按收费标准较高的特殊治疗价格项目就高收费，不叠加计费。

读要网会员内部资料仅供参考